جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) *

طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : مروه بيومي احمد بيومي

المحافظة : القاهره **الحي / المدينة :** المقطم **العنوان :** حي الاسمرات

رقم البطاقة : 28708010108347 **رقم التليفون :** 01142816435 **تاريخ تسجيل الإستمارة :** 11-10-2026

العمر(تاريخ الميلاد) : 01-08-1987 **المهنة :** ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي **المقر بما فيه**

التوقيع:(----------) **التوقيع:**(----------)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : علاج مبادرة سرطان الثدي علاج هرموني خط ثاني مثبطات الاروماتيز [14161] **قسم العلاج :** الاورام

التعليق على التشخيص : ----------

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

الاسم: د/ندى حسن **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

الاسم: د/نرمين رمضان **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة و مدير المستشفي.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفي قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

ا.د/ ---------- **ا.د/** ---------- **د/** ---------- **د/** ----------

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : ----------
خطة العلاج : ----------
المستشفي : ----------**قسم :** ----------
جهة العلاج : ----------**نفقات :** ----------
ملاحظات : ----------

رئيس	مدير عام	ختم
المجلس الطبي المتخصص	مديرية الشئون الصحية	شعار الجمهورية

Name: مروه يومي احمد يومي
National ID: 28708010108347

تقرير طبي

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انة

المريضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي Second Line Hormonal Treatment Aromatase Inhibitor

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين


جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية
مروة
بيومى أحمد بيومى
٤٣ الصفا - حى الاشجرات
المقطم - القاهره
٢٨٧٠٨٠١٠١٠٨٣٤٧
LL0870764


ربة منزل
انثى
مسلمة
متزوجة
محمد حسنى بكر يوسف
البطاقة سارية حتى

Patient Name	: الأستاذه / مروه بيومى احمد	Request No.	: 13000141
Patient No.	: 28708010108347	Request Date	: 29/04/2023
Path No.	: 1212/23	Verification Date	: 16/05/2023
Sex	: Female	Financial Category	: اوراو دار السلام - مباشره
Age	: 38 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc.	:	IHC No.	:
		Registered by	: .marwa mohamed yousse

IMMUNOHISTOCHEMISTRY REPORT

Clinical Data: Right breast mass.

Nature of Specimen: Tru-cut biopsy, collected at 27/4/2023, 12:40 pm.

Gross Examination:
- Multiple grayish white tissue cores up to 1.5 cm, totally submitted.

Microscopic Examination:
* Histological type: Invasive duct carcinoma.
* Grade (differentiation+ nuclear pleomorphism+ mitosis): (3+2+1) Grade II .
* Ductal carcinoma in situ: No.
* Perineural invasion: No.
* Angioinvasion: No.
* IPT (Positive control showed appropriate reactivity):
- ER: Moderate nuclear reaction in 70% of tumor cells (Allred score 7/8).
- PR: Moderate nuclear reaction in 10% of tumor cells (Allred score 4/8).
- Her2: Strong complete membrane reaction in >10% of tumor cells (score 3+).
- Ki67: 70% nuclear reaction of tumor cells.

Diagnosis:
Right breast mass, Tru-cut biopsy:
Invasive duct carcinoma., Grade II .
IPT:
- ER: Positive (score 7/8).
- PR: Positive (score 4/8).
- Her2: Positive (score 3+).

Verified by :

غرفة رقم (4) – الدور الأول – مبنى رقم (987) – كورنيش النيل – مصر القديمة – القاهرة – مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Name: مروه بيومى احمد **MR. :** 1066	

Detailed Medical Report

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من		**بشأن تقرير طبي للمريض**	
بقسم:		**رقم طبي:**	

ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول : | **تاريخ وساعة الخروج :**

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه

The patient is a 38-year-old individual with de novo metastatic breast cancer to the lymph nodes diagnosed in July 2023. Pathology revealed invasive ductal carcinoma, estrogen receptor (ER) 7/8, progesterone receptor (PR) 4/8, and HER2 + 3. The patient received 36 weeks of trastuzumab (Herceptin) and continued weekly paclitaxel (Taxol). Trastuzumab was administered subcutaneously. A dermatology consultation was requested for a skin rash attributed to the therapy. The patient was also placed on anastrozole (Arimidex) and calcium supplementation (1 tablet × 1 × 90). A recent CT of the chest, abdomen, and pelvis (CT CAP) showed a Zoladex (goserelin) level of 10.8 ng/mL on 6 February 2026, and a bone scan was performed.

The patient continues to be managed for metastatic breast cancer involving the lymph nodes with ongoing anastrozole and trastuzumab therapy, as well as goserelin (Zoladex). The regimen has been maintained for three months.

The patient remains on trastuzumab, goserelin, and anastrozole. A PET-CT demonstrated mediastinal lymph node involvement and a tiny lung nodule. Further imaging with CT chest, MRI cervicodorsal spine, and MRI pelvis is planned, along with tumor marker assessment, and the case will be reviewed at multidisciplinary tumor board.

تحريرا في ,

التاريخ : 21-09-2026 **الوقت :**

الطبيب المعالج : ايه مدحت بدوي محمد

يعتمد ,

Patient Name	الأستاذه / مروه بيومى احمد	Request No.	13000141
Patient No.	28708010108347	Request Date	29/04/2023
Path No.	1212/23	Verification Date	16/05/2023
Sex	Female	Financial Category	اورام دار السلام - مبادره
Age	38 Y	Department	Out Patient
Referreing Doc.			
		Registered by	.marwa mohamed yousse

IMMUNOHISTOCHEMISTRY REPORT

- Ki67: Positive in 70% of tumor cells.

Signature
Dr. Rana Fathy
Dr. Menan Hossam

Verified by :

غرفة رقم (4) – الدور الاول – مبنى رقم (987) – كورنيش النيل – مصر القديمة – القاهرة – مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

كايرو سكان
CAIRO SCAN

Name : Mrs. Marwa Bayoumi Ahmed Bayoumi
Date : 16/04/2023 Code : R2757882

3d full field DIGITAL MAMMOGRAPHY AND TOMOSYNTHESIS EXAMINATION OF BOTH BREASTS:

CLINICAL SUMMARY: 40 yrs old female patient , right palpable breast mass
IMPRESSION:
RIGHT BREAST (BIRADS 5): UOQ malignant mass with pathologically enlarged axillary LN
LEFT BREAST (BIRADS 1): normal study.
RECOMMENDATION:
- Biopsy from malignant mass, MRI is advisable to detect actual extension , role out multicentricity, multifocality , metastatic work up

TECHNIQUE:
Craniocaudal & Mediolateral Oblique views
High resolution ultrasound
Tomosynthesis in 0.5mm slice thickness

DETAILED FINDINGS:

Breast composition:
The breasts show scattered fibroglandular tissues (ACR b)

Right Breast:

- RUOQ 11 o'clock speculated irregular shaped dense mass, surrounding architectural distortion , another adjacent faint mass noted .
- Additional ultrasound revealed RUOQ speculated irregular shaped hypoechoic mass taller than wider , antiparallel , with posterior acoustic shadowing & surrounding hyperechoic margin ? desmoblastic reaction , showing minimal internal vascularity, measures 25x30 mm , another similar one 15x12 mm with intervening space about 4 cm , surrounding architectural distortion ? parenchymal infiltration
- Normal skin thickness and contour.
- Normal retro-areolar ductal system.
- Normal nipple/areola complex.
- Pathological enlarged axillary lymph nodes showing loss of hilum , largest 20x19 mm

...oumi Ahmed Bayou... Code ... ...OSYNTHE...

Imaging report

Name : Mrs. Marwa Bayoumi Ahmed Bayoumi
Date : 16/04/2023 Code : R2757882

Left Breast:

- No suspicious masses, calcifications, asymmetry, or architectura distortion.
- Additional ultrasound revealed normal parenchyma, with no solid no cystic lesions
- Normal skin thickness and contour.
- Normal retro-areolar ductal system.
- Normal nipple/areola complex.
- No abnormal axillary lymph nodes.

Sincerely,

Dr. SHEREEN ALI , FEBR

For any inquiries regarding the findings in the report please contact us on radreport@cairoscan.com.eg

Name: Marwa Baiomy Ahmed

Date: 27th May 2023

Contrast enhanced Spectral Mammography

Clinical summary: Right breast invasive duct carcinoma grade II

CC & MLO low energy & recombined (post contrast) images

FINDINGS

Background Uptake: mild background enhancement

ACR: b (scattered fibro-glandular densities)

RIGHT BREAST

- **Low energy (Non contrast) images:**
  - **Upper outer quadrant, anterior & middle thirds**; irregular shaped spiculated margin hyperdense lesion associated focal asymmetry and distortion
  - **Upper outer & inner central**; middle thirds focal asymmetry
- **Recombined (Post contrast) images:**
  - **Upper outer quadrant, anterior and middle thirds relatively rounded, indistinct margin marked heterogeneous mass enhancing lesion measuring 2.8 x 3.2 x 3.3 cm in CC, AP & Transverse diameters** respectively and about 3.6 cm distance from the nipple blending with segmental marked heterogeneous non-mass enhancing lesion with overall area of enhancement measuring 9.8 x 4.8 cm in average and about 3 cm distance from the nipple in MLO view
  - **Upper outer and inner central**; ill-defined faint heterogeneous non-mass enhancing lesions more evident in CC view, measuring respectively from outer to inner 2.3 x 1.6 cm and 1 x 0.4 cm and about 6.6 cm distance from each other and 3 cm & 7.2 cm distance from the index lesion respectively
- Normal skin / nipple / areolar complex.
- **Complementary US:**
  - **Upper outer quadrant 10-11 o'clock**; irregular shaped spiculated margin heterogeneous hypoechoic solid lesion with non-parallel orientation and posterior acoustic shadowing
  - **10 o'clock ill-defined area of altered parenchymal echogenicity corresponding to the other area of non-mass enhancement**
  - **The other smaller non-mass enhancement area not correlated with ultrasound lesion**
  - **More than three level I axillary lymph nodes**; with focal cortical thickness and indented hilum up to 0.8 cm. At least two of them showing irregular shaped spiculated margin with the largest measuring 1.9 x 2.2 cm in average with features suggestive of extra-capsular rupture

LEFT BREAST

- **Low energy (Non contrast) images** No masses, asymmetry or distortion or suspicious microcalcifications.
- **Recombined (Post contrast) images** show, no pathological uptake.
- Normal skin / nipple / areolar complex.

IMPRESSION

RIGHT BREAST: multifocal pathological proved malignancy with pathological lymph nodes with features of extra-capsular ruptures as described (BIRADS 6)

LEFT BREAST: (BIRADS 2nd benign)

Best regards,

Prof. Dr. Lamiaa Adel, MD

Female /Breast Imaging & Intervention Consultant

Cairo University

Ministry Of Health
Specialized Medical Centers
Dar El Salam Cancer Hospital
Radiology Department

وزارة الصـــــحة والسكـــان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى أورام دار السلام
ادارة الاشعة

Patient Name: Marwa Bayoumi Ahmed Bayoumi	Date : 05/05/2025
Exam : C.T ABDOMEN &PELVIS	Age : 37 Year(s)
Medical ID: 1720/2023	Pat. ID: 97209

NON-CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST, ABDOMEN & PELVIS REVEALED:

- **Compared to the previous study dated 27/01/2025.**

Chest:

- **Rather stationary:**
  - Right axillary level I subcentimetric lymph nodes.
  - Enlarged bilateral hilar and mediastinal lymph nodes, the largest at right paratracheal still measures about 2.6 x 4 cm.
  - Size of bilateral pulmonary nodules largest at right upper lobe measuring 6 mm.
- No evidence of pleural effusion, or masses seen.
- Average cardiac size. No pericardial effusion detected.

Abdomen and pelvis:

- The liver is enlarged with homogenous CT texture. No definite focal lesions on non-contrast basis or contour irregularities on non contrast basis.
- No intra-hepatic or extra-hepatic biliary radicles dilatation.
- Normal size & parenchymal texture of the spleen with no focal lesions seen.
- No pathological abdominal or pelvic lymph nodes.
- Mal rotated inferiorly located right kidney. Otherwise, Normal size, parenchymal thickness & density of both kidneys with no stones or back-pressure changes.
- Normal appearance of the pancreas and both supra-renals.
- Smooth filling of the urinary bladder with no filling defects or diverticular outpouching.
- Normal appearance of the other pelvic organs.
- No abdominal or pelvic masses or collections.
- No definite lytic or sclerotic lesions.
- No vertebral structural collapse or extra-osseous soft tissue component.

OPINION:

Status follow up showing:

- **Overall stationary course as described.**

Dr. Mohamed Mohsen, M.D.